APTT クロスミキシングテストにおける各種判定法の診断能についての比較検討

◎武村 友貴[1)]、竹内 達哉[1)]、鈴木 秀幸[1)]、鈴木 久美子[1)]、梶口 智弘[2)]、中村 美子[1)]
公立陶生病院 臨床検査部[1)]、公立陶生病院 血液・腫瘍内科[2)]

【緒言】APTT クロスミキシングテスト（以下,CMT）は APTT 延長症例の鑑別に用いられる検査である。近年,その判定には Rosner index（ICA 法）に加え,WaS 法,ALD50 法,重み付き調和平均を用いた判定方法,など複数の定量指標が報告されている。しかし,これらの Cutoff 値や有用性は試薬や測定条件に依存するため自施設での検証が必要である。一方,APTT-SP（Werfen）を用いた検討はこれまで報告が少ない。そこで本研究では,APTT-SP を用いた CMT において各判定法の診断能を比較検討した。

【対象と方法】2013 年 6 月から 2023 年 5 月に当院で CMT を実施した 176 例を後方視的に検討した。判定法は波形パターン法,ICA 法,ALD50 法,重み付き調和平均を用いた判定方法（混和直後：IHMi, 2 時間加温：IHMd）とした。対象を LA 陽性（LA 群）,凝固因子欠乏（FD 群）,凝固因子インヒビター（INH 群）に分類したが,INH 群は 1 例と少数であったため,主に LA 群および FD 群を対象に解析した。群間比較には Mann-Whitney U 検定,診断能評価には ROC 解析を用いた。

【結果】すべての定量指標において LA 群と FD 群の間に有意差を認めた（p<0.05）。ROC 解析では,IHMi が最も高い AUC を示し（AUC=0.857）,次いで ICA 法であった（AUC=0.841）。LA 検出において IHMi は感度 72.0%,特異度 94.7%（Cutoff 値:1.02）,ICA 法は感度 79.2%,特異度 84.0%（Cutoff 値:11.7）であった。

【考察】ROC 解析において,IHMi は最も高い AUC を示し,特に特異度に優れていた。一方,ICA 法は感度と特異度のバランスに優れる傾向が認められた。このように各判定法には異なる特性があり,CMT の結果解釈には単一の指標のみで判定するのではなく,波形パターン法,ICA 法,および IHMi 等の数値判定法を相補的に組み合わせて評価することが CMT の信頼性向上に寄与する可能性が示唆された。

【結論】APTT-SP を用いた CMT において、各判定法は異なる検出特性を示した。各判定法の特性を理解し,波形パターン法と複数の定量法を併用することは,本検査の信頼性を高める上で有用である。

連絡先：0561-82-5101(内線：4111)